

Anamnèse Sexuelle

0. Cadre général

La sexualité fait notamment intervenir les termes de **genre**, d'**orientation** et de **pratiques** (pas toujours tous en adéquation !), mais également la pensée, le sentiment et le vécu.

Cadre **légal** de la sexualité : pédophilie doit être déclarée, ainsi que tout autre pratique pouvant faire du mal à autrui.

1. Physiologique de la sexualité

Avant, il y a encore une **phase de désir** : chaque phase peut être associée à des troubles particuliers.

- a. Phase d'excitation
- b. Phase de plateau
- c. Phase de l'orgasme
- d. Phase de résolution

Parfois dans l'anamnèse sexuelle, il faut **juste informer le patient** !

La taille du pénis et le point G sont des objets de fantasmes, de discours, de marchandises. Ils constituent donc **plus qu'une réalité biologique**.

2. Anamnèse sexuelle au cabinet

Les consultations pour des problèmes sexuels **représentent près de 15% des consultations totales**. Les sujets couramment abordés sont les dysfonctions sexuelles, les orientations sexuelles, les abus et violences sexuelles, les MST, les grossesses (désirées ou non) et les infertilités.

Plus de 95% des patients jugent normal que le médecin **investigue la sphère sexuelle** !

Il existe plusieurs émotions fortement liées à la sexualité, **angoisse, dégoût, culpabilité, honte et gêne** (fait que l'on n'en parle pas) qui nous guident. La **honte** est très liée au fait que **l'on se sent différent** des autres (conformisme actuel). La honte **signale la différence** et peut amener à faire des chose idiotes pour se conformer aux autres = **sentiment social**

3. Conditions générales de l'anamnèse sexuelle

Les patients dévoilent ce que le médecin peut entendre (et ne peuvent d'ailleurs que dire certaines choses à certaines personnes => toujours demander aux autres soignants si le patient s'est ouvert à eux !). Il faut reconnaître ses **propres attitudes, angoisses et gênes** (qu'est-ce que je pense des perversions, des prostituées ?). Il est important **de connaître ses limites** et orienter le patient ailleurs.

Un point important est le **choix du langage** : il est très difficile, mais très important, de savoir trouver les mots et de poser les bonnes questions pour **éviter de paraître trop insistant, trop gênant**, au risque de voir le patient se refermer sur lui-même et de se rétracter.

- a. Comment entrer en matière sur le champs de la sexualité : chercher les portes d'entrée (ganglions, fatigue, qui se déploie sur le champs de la sexualité)
- b. **Expliciter le secret médical** et ne pas hésiter à rappeler qu'on se trouve dans un cabinet médical, ce qui signifie que tout ce qui est dit est strictement confidentiel

- c. **Nommer le climat émotionnel** : je comprends que c'est difficile pour vous de parler de ce genre de sujet, surtout s'il y a une différence d'âge et de sexe entre nous. Si certains sujets sont trop gênants ou si vous trouvez mes questions trop insistantes, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à m'interrompre à tout moment
- d. **Langage adapté** : attention à la rationalisation
- e. **Investigation** : on ne fait pas une inquisition (patient toujours libre de répondre ou non)
- f. **Présence de symptômes** : il faut les décrire et les contextualiser (contexte relationnel qui s'inscrit dans une vie)
- g. **Rassurer sur la normalité** : de nombreux patients viennent en pensant avoir des problèmes anormaux touchant à la sexualité, notamment concernant la taille de leur pénis ou encore leur homosexualité ; dans ce deuxième cas, il est important de rassurer le patient en lui affirmant que même si cette sexualité est minoritaire, elle n'est **en aucun cas** un problème psychiatrique ou une 'maladie' dont il faudrait avoir honte

Il est aussi important de garder à l'esprit la **déontologie médicale**, qui n'interdit pas de ressentir de l'attirance envers les patients, mais qui condamne toute forme d'attouchement ou autre forme de pratiques touchant à la sexualité avec les patients dans le domaine du médical.

4. Sexualité et dysfonctions sexuelles

La sexualité correspond à toute forme **d'expression ou de manifestations consciente ou inconsciente de l'identité sexuée et de l'imaginaire érotique** (usage sexuel du non-sexuel comme le pouvoir et l'argent, et usage non-sexuel du sexuel comme le viol). Les trois principaux problèmes liés à la sexualité sont les troubles **du désir, de l'excitation et du plaisir**.

4.1. Troubles du désir (anhédonie, aversion ou hypersexualité)

Certaines personnes **ressentent moins de désir**, plus de désir, voire parfois même une aversion (provient forcément d'une expérience traumatisante, comme un viol) pour la sexualité. Les troubles du désir peuvent avoir de nombreuses origines : **troubles psychiatriques** (dépression (enlève tout plaisir !), troubles bipolaires), maladies somatiques (ex. : artériosclérose, qui peut toucher le pénis dans les phases tardives et rendre les érections très difficiles), **effets secondaires de médicaments** (antidépresseur, chimiothérapies (ex. : comme ce traitement détruit les muqueuses, les femmes ressentent beaucoup de douleurs pendant les rapports !)), contexte relationnel, angoisse, pression, **traumatisme et éducation**.

Les troubles du désir peuvent aussi être dans l'autre extrême, c'est à dire l'hypersexualité ou d'addiction.

Chez la **femme**, la perte du désir constitue le trouble sexuel le plus **fréquent**, particulièrement après la naissance de l'enfant. Chez l'homme, le trouble du désir apparaît souvent dans les contextes de **burn-out**.

4.2. Trouble de l'excitation

Le trouble de l'excitation chez les femmes se traduit principalement par une **diminution de la lubrification**. Ce phénomène est physiologique avec le vieillissement de la femme à cause de la diminution de la quantité d'oestrogènes. En revanche il est pathologique chez la femme jeune.

Chez les hommes, c'est les **problèmes d'érection** qui prédominent. La prévalence augmente également avec l'âge (50% pour les patients de 70-80 ans). Le trouble de l'érection est souvent lié à une **maladie somatique**, par exemple les manifestations coronariennes. Il s'ancre aussi dans un contexte relationnel important.

De manière générale, cette excitation peut être **hypertrophiée** (ex. : maniaques, qui sont trop impliqué dans tout), ou au contraire **diminuée**, voir absente (ex. : on peut avoir un désir, mais pas d'excitation, comme chez les femmes avec une diminution de la lubrification).

4.3. Troubles du plaisir

Le trouble du plaisir est une **insatisfaction**, particulièrement en l'**absence d'orgasme** (ex. : on pourrait avoir un désir, une excitation, mais une absence totale d'orgasme). Chez la **femme** (10% à 20% avec anorgasmie ou insatisfaction !), il est souvent dû à un rapport au corps non-satisfaisant, sentiment de culpabilité, une relation non-satisfaisante ou des angoisses. Des douleurs sont elles plutôt associées à des traumatismes.

Chez l'homme, le problème le plus fréquent **c'est l'éjaculation précoce** (trouble sexuel le plus fréquent qui génère une forte sensation de honte)

4.4. Paraphilies

Explorer les éventuelles '**déviances**' **sexuelles**, comme le SM par exemple

4.4. Dysphories

Explorer les éventuels troubles de l'identité sexuelle

5. Approfondir l'investigation

Lors de l'anamnèse sexuelle, il est important **d'approfondir au mieux la plainte**. Il faut déterminer le contexte dans lequel émerge le trouble, sa fréquence, sa durée, intensité et ses conséquences.

Les contextes **mentaux, sociaux et culturels** doivent être pris en compte. Le regard sur soi-même, sa perception des autres, ses fantasmes, la contraception, le désir d'enfant et la communication avec le partenaire sont également des points importants à aborder.

Enfin, il est souvent utile **d'en savoir plus sur la vie**, la biographie de la personne, c'est à dire la sexualité dans sa famille, la présence de situation abusive, le nombre de partenaires, l'éducation et la religiosité reçues pendant l'enfance.

On s'intéresse aussi **à l'émergence de la sexualité** et donc le rôle clé de la puberté (traumatisme, masturbation). En somme, il est important de cerner le trouble mais aussi de savoir dans quel contexte il s'inscrit.

6. Aspects supplémentaires de la sexualité dans le cabinet médical

On peut aussi aborder les points suivants :

- Discours de prévention et comportements à risques (important chez les jeunes)
- Contraception et grossesses, désirées ou non
- MST
- Problèmes de couple
- Dysphorie de genre
- Effets secondaires des médicaments prescrits (en général et sur la sexualité)

7. Séquence de l'anamnèse

- 1) Trouver une porte d'entrée

- 2) Expliciter le secret médical et c'est le patient qui décide de ce qui sera fait/des questions que l'on peut lui poser. **Demander s'il est déjà aller chercher une aide pour son problème, pourquoi il est venu consulter maintenant et ses attentes**
- **3) Caractérisation du trouble** (mêmes étapes que pour la douleur + **ce que lui et son partenaire pensent du problème + impact sur la vie quotidienne**) **et anamnèse urologique**
- 4) **Rechercher des troubles du désir** (signe parfois des envies suicidaires !), **de l'excitation et du plaisir (important de rechercher si les rapports sont satisfaisants !)**
- **5) Biographie**
 - Rechercher des **maladies/traitements/opérations/problèmes psychiatriques** (dépression ou burnout surtout !) pouvant expliquer son problème (ex. : diabète/athérosclérose/fumée et dysfonctions érectiles)
 - **MST/IST précédentes ?**
 - Famille, relations dans la famille, communications dans la famille, relations extra-conjugales
 - Religion et religiosité
 - Recherche de situations particulières (ex. : accouchement, violences, etc.)
 - **Recherche d'abus**
 - **Recherche de traumatismes**
- 6) Adolescence, apparition de la sexualité, masturbation, premiers contacts sexuels
- **7) Orientation sexuelle**, sa perception et son vécu
- **8) Partenaire/partenaires, type**, éventuels problèmes de couple
- **9) Types de rapports** (« classiques », comme oral, vaginal ou anal, mais aussi SM, fétiches, etc.) et leur perception (= paraphilies)
- **10) Types de protections utilisées** (si pas préservatif, renseigner et faire de la prévention pour les MST ! Par exemple, oui la pilule est efficace pour éviter les grossesses, mais ne protège pas des MST ; la PreP ne protège elle que du VIH, mais pas de toutes les autres MST !)
- **11) Le regard des autres** (stress, peur, etc.)
- **12) Contexte relationnel**
 - (Répétitions : partenaire, pratiques, regard des autres)
 - Tendresse
 - **Communication avec le partenaire/les autres => difficultés dans sa relation sentimentale ?**
 - Représentations
 - Désir d'enfants, contraception
 - Sexualité souvent tout premier reflet des problèmes de couple !
- 13) Aborder les dysphories
- **14) Prévention, MST et dépistage** (= en remettre une couche !)
- 15) Évoquer un examen de l'abdomen, et si on a affaire à une patient, un examen gynécologique

Remarque : un bon mémo est les « 5P », qui sont : (1) Pratiques (ex. : rapports oraux ou vaginaux), (2) Partenaires (= hommes uniquement ?), (3) Protection (et si la personne sait de quoi elle la protège et de quoi elle ne la protège pas), (4) Passé (= déjà des MSTs ?) et (5) Prévention de la grossesse